

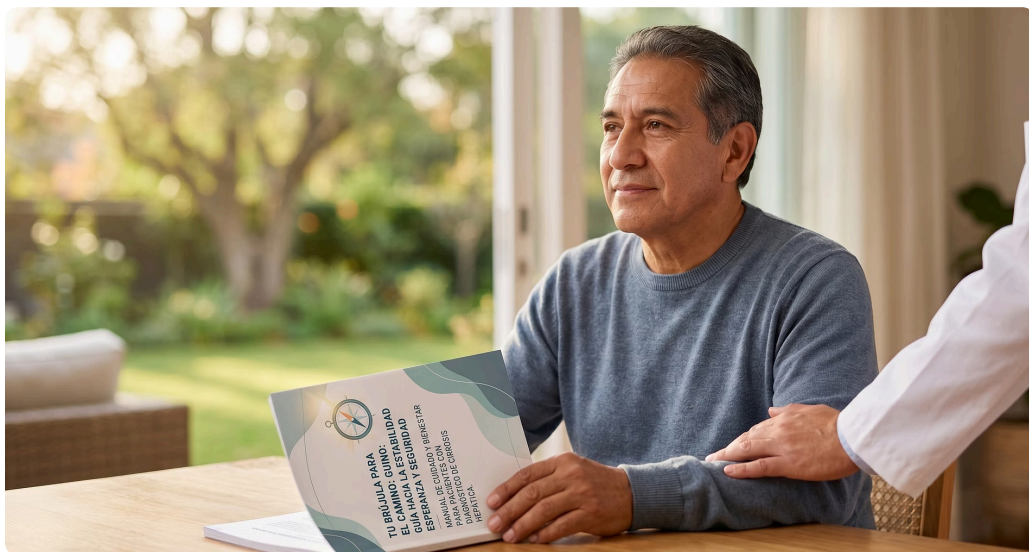
Descompensaciones Evitables en Cirrosis hepática



by Julio Santiago Marcelo



DR. JULIO SANTIAGO MARCELO
GASTROENTERÓLOGO



1. Un Nuevo Camino hacia la Salud

Recibir el diagnóstico de cirrosis hepática puede ser un momento de gran incertidumbre, pero debes saber algo fundamental: este diagnóstico no es una sentencia de muerte. Como especialistas, vemos a diario que la estabilidad y la condición del paciente son objetivos alcanzables. No estás solo en este proceso.

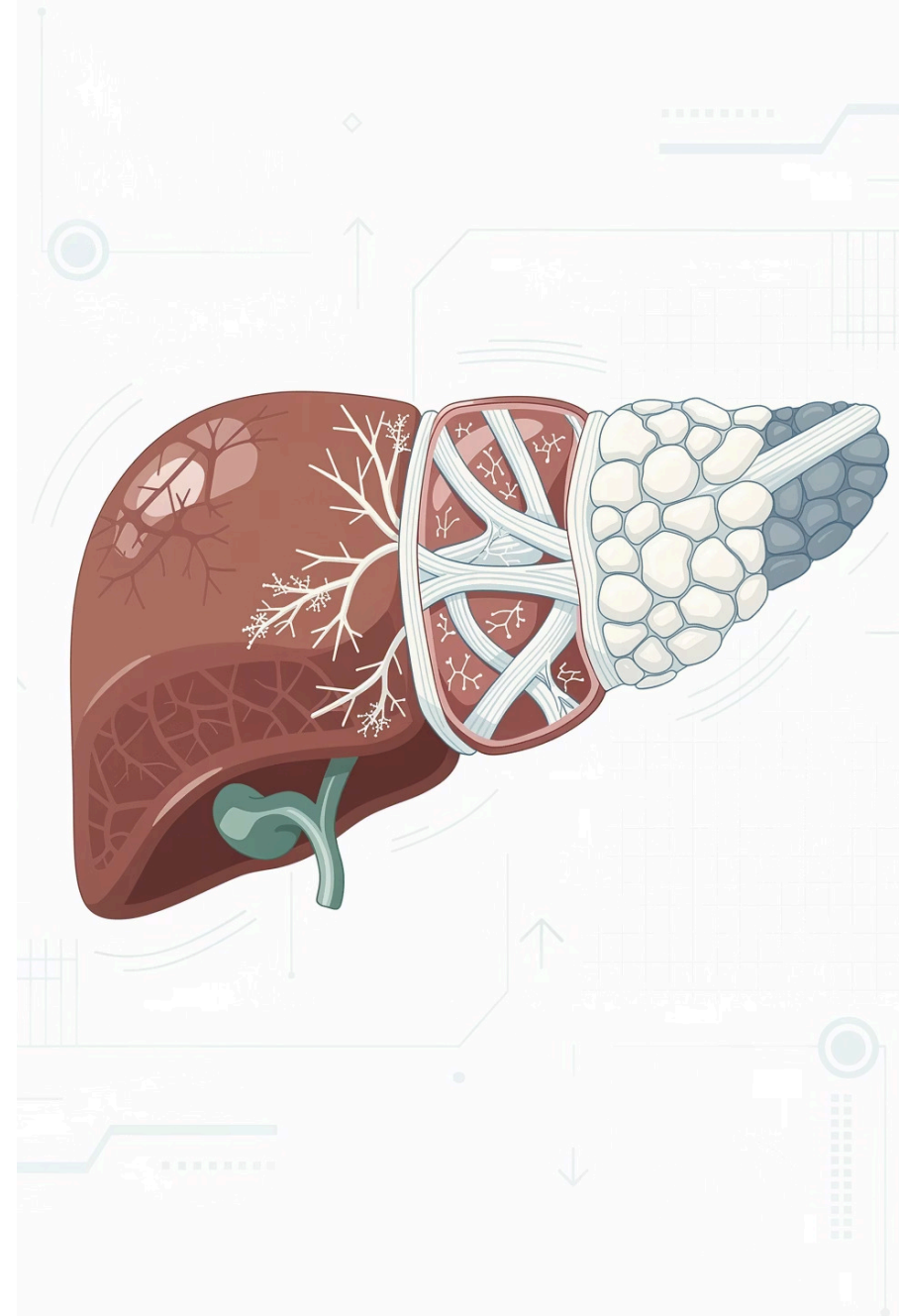
Con el cuidado adecuado, disciplina y trabajo en equipo, podemos transformar este desafío en un camino de mejoría y bienestar. La estabilidad de la enfermedad depende de las acciones que tomemos hoy; este documento es su brújula para transitar este camino con seguridad y esperanza.

2. Comprendiendo la Enfermedad: ¿Qué es la Cirrosis?

La cirrosis no ocurre de forma repentina; es el resultado de un proceso de "endurecimiento del hígado" de forma silenciosa, se le conoce como fibrosis. Imagine que su hígado, al intentar defenderse de agresiones constantes, comienza a generar "cicatrices" (fibrosis). Con el tiempo, estas cicatrices reemplazan al tejido sano y dificultan el paso de la sangre. Aunque no siempre podemos eliminar las cicatrices ya existentes, sí podemos detener la formación de nuevas cicatrices controlando la causa raíz:

- Consumo de alcohol.
- Obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, HTA, triglicéridos altos.
- Infecciones por virus de la hepatitis B y C.
- Enfermedades autoinmunes
- Otras menos frecuentes

Si no controlamos el peso, el azúcar o el consumo de alcohol, la enfermedad seguirá avanzando sin importar qué medicamentos tome. El control está en sus manos.



3. Los Cuatro Pilares del Éxito en el Tratamiento

El éxito para mantener la enfermedad estable no depende de un fármaco "milagroso", sino de una estrategia conjunta que aborda múltiples facetas de su bienestar.

Atención médica especializada

Nutrición especializada

Actividad física

Apoyo familiar

4. Reglas de Oro de la Nutrición

En la cirrosis, la nutrición es vital. El objetivo es evitar que su cuerpo "se coma" sus propios músculos para obtener energía.

- **Frecuencia vital:** Debe realizar entre **5 y 6 comidas al día** .
- **El peligro del ayuno: EL AYUNO DE MÁS DE 12 HORAS ESTÁ Estrictamente Prohibido.** Para una persona con cirrosis, pasar una noche sin comer equivale al desgaste que sufriría una persona sana tras **2 o 3 días de ayuno total** . Esto provoca una pérdida de masa muscular acelerada y peligrosa.
- **Proteína para la fuerza:** Su dieta debe ser alta en proteínas, consumiendo de **1.2 a 1.5 gramos por cada kilo de su peso** para mantener sus músculos fuertes.
- **Prohibiciones y recomendaciones:** Están prohibidas las hierbas **medicinales** ya que pueden ser tóxicos y causar fallos graves. Por el contrario, el **café pasado** se puede tomar sin problemas, salvo indicación médica.

Mito – Realidad: "Si tengo líquido en el abdomen (ascitis), no debo tomar agua". | **Falso.** Usted puede y debe beber agua. El verdadero culpable de la retención de líquido es el **exceso de SAL**, no el agua.



5. Actividad Física: Fortaleciendo el Cuerpo desde Casa

Es vital entender que **estar en cama no es descansar, es debilitar su cuerpo**. El reposo prolongado puede acelerar la pérdida de músculo, lo cual empeora su pronóstico.

Lo recomendable es acudir a terapia física. Te dejo algunas recomendaciones generales:

1. **Ejercicios de fuerza:** Use pesas ligeras (1 a 5 kg), botellas con agua o arena, o bandas elásticas.
2. **Use su peso:** Ejercicios simples como pararse y sentarse de una silla repetidamente ayudan a fortalecer las piernas.
3. **Para pacientes frágiles:** Si se siente muy débil, no se detenga; realice estiramientos básicos o solicite terapia física guiada en casa para mantener la movilidad.



6. Guía de Medicamentos: Seguridad y Riesgos

El hígado con cirrosis es muy sensible. Un medicamento común puede convertirse en un peligro si no se usa con precaución. **NUNCA consuma AINEs (antiinflamatorios no esteroideos)** como Ibuprofeno, Naproxeno o Diclofenaco. Esto aplica para **PASTILLAS E INYECCIONES**, por igual. Estos fármacos pueden provocar úlceras y hemorragias digestivas que ponen en riesgo la vida del paciente. **NO use antibióticos como Amikacina o Gentamicina**, ya que puede afectar a sus riñones.

Uso seguro de medicamentos permitidos:

- **Para dolor o fiebre:** Use Paracetamol (**Panadol**). La dosis máxima absoluta es de **2 gramos (2000 mg) al día**.
- **Resfríos comunes:** Use antigripales sencillos, siempre verificando que en su composición no **contengan AINEs**.
- **Golpes y dolores musculares:** Use hielo para golpes nuevos (agudos). Use compresas **de calor** para dolores crónicos de varios días (como dolor lumbar). Los geles antiinflamatorios se permiten solo si usted está estable y por periodos muy breves.



7. Señales de Alarma: Cuándo Acudir a Urgencias

Aprender a identificar estos síntomas puede salvar su vida. Ante cualquiera de estos signos, busque ayuda médica inmediata:

Hemorragia Digestiva

Identifique la **hematemesis** (vómitos con sangre) o la **melena** . La melena consiste en heces negras como la brea, pastosas, brillantes y con un olor fétido muy intenso y desagradable.

Fiebre e Infecciones

La fiebre es una emergencia. Las infecciones descompensan el hígado rápidamente. La prevención es clave: **es obligatorio vacunarse** contra Influenza (anual), Neumococo, Hepatitis A y Hepatitis B.

Encefalopatía Hepática (Desorientación).

Ocurre cuando el amoníaco se acumula en el cerebro. El primer signo es la pérdida **de la noción del tiempo** .

- **Si ya ha tenido encefalopatía antes:** Debe usar lactulosa para asegurar **2 a 3 deposiciones blandas al día**. Si no va al baño, aumente la dosis cada hora y si no hay respuesta use un enema.

- **Si nunca ha tenido encefalopatía:** Si es regular (incluso yendo una vez al día) y está compensado, no **necesita lactulosa** .



8. Manejo de Complicaciones Cotidianas

- **Plaquetas bajas:** Es común que bajen debido a que la presión en el hígado hace que el **bazo crezca (esplenomegalia)** y las destruya. **No suben comiendo alimentos especiales.** El médico controlará esto con medicamentos como Carvedilol o Propranolol.
- **Picazón (Prurito):** Evite las duchas de agua caliente, ya que el calor empeora la picazón. Mantenga las uñas cortas para evitar heridas, use cremas humectantes dos veces al día y prefiera baños con agua fría.
- **Insomnio:** No use pantallas (celular, TV) después de las 8:00 p.m. Use música relajante o sumerja los pies en agua tibia con lavanda antes de dormir.





9. Conclusión y Compromiso Familiar

Vivir con cirrosis hepática requiere disciplina, pero el resultado de ese esfuerzo es la vida misma. El papel de la familia no es solo observar, sino ser parte del equipo junto a la nutrición, el ejercicio y la medicación del paciente. Con una adherencia estricta y manteniendo una actitud optimista, es posible mejorar este diagnóstico en una etapa de estabilidad y bienestar. ¡Sigamos adelante con fuerza!

Guía para una Cirrosis Estable: Cuidados Diarios y Alertas

La cirrosis requiere un manejo integral. El éxito depende de la atención médica, nutrición, actividad física y apoyo familiar para evitar complicaciones.

Pilares del Bienestar Diario



Nutrición sin ayunos

Come de 5 a 6 veces al día; pasar más de 12 horas sin comer daña tus músculos.



Proteína y Agua son Clave

Consume una dieta alta en proteínas y no temas al agua; lo que hincha es la sal.



Fortalece tus Músculos

Realiza ejercicios de fuerza con pesas pequeñas o parándote y sentándote de una silla.

Seguridad y Signos de Alarma



¡Medicamentos Prohibidos!

Nunca uses Ibuprofeno, Naproxeno o Diclofenaco; pueden causar hemorragias mortales.

Cirrosis 360°

| Dr. Julio Santiago Marcelo



Señales de Emergencia

Acude a urgencias por heces negras, vómitos con sangre, fiebre o confusión mental.



Prueba de Orientación

Si el paciente no sabe el año actual o no nombra 15 animales por minuto, busca ayuda.